·研究报告·

“风癔”病证考略

王露凝[1]，陈仁寿[2]

（[1]东南大学附属中大医院，南京 210009；[2]南京中医药大学中医药文献研究院，南京 210023）

摘要：“风癔”作为病名首见于《诸病源候论》，主要表现为突发性言语障碍与肢体瘫痪，病重者可伴意识障碍。不同朝代的医家对“风癔”有不同的认知，唐宋时期多从“风”立论，主祛风通络、解表通里之法，方选独活汤等；金元以后多从“痰”立论，主化痰开窍、补虚行气之法，方选牛黄清心丸等。文章梳理归纳了“风癔”的病名、病机、治法、方药，为临床治疗急性脑血管病提供思路。

关键词：风癔；卒中；言语障碍；考略

Textual research on ‘wind hysteria’

WANG Luning[1], CHEN Renshou[2]

([1]Zhongda Hospital Southeast University, Nanjing 210009, China; [2]Institute of Chinese Medical Literature, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210023, China)

Abstract: The first occurrence of ‘wind hysteria’ is found in *Treatise on Causes and Manifestations of Various Diseases*, which mainly manifested as speech disorder and limb paralysis, and serious patients may be accompanied by consciousness disorders. Doctors in different dynasties had different understandings of ‘wind hysteria’. In the Tang and Song dynastyies, the doctors take the wind as the main cause. The treatment is dispeling wind to free the collateral vessels, releasing the exterior and using Duhuo Decoction. In the Jin and Yuan Dynasties, the phlegm is considered as the main cause. The treatment is resolving phlegm to open the orifices, tonifying and moving qi, using Niuhuang Qingxin Pills. This paper concludes the concept, pathogenesis, treatment and prescriptions of‘wind hysteria’. It provides reference for the modern diagnosis and treatment of acute cerebrovascular diseases.

Keywords: Wind hysteria; Sudden stroke; Speech disorder; Textual research

“风癔”为中医古病名，以突发性言语障碍、肢体瘫痪为主症，病重者可伴意识障碍，现代主要见于急性脑血管病中的后循环脑血管病变。探讨“风癔”的病因病机和治法方药，对于临床辨治急性脑血管病具有重要意义。因此，本文从文献考证的视角，系统梳理古典医籍中关于“风癔”的论述。

病名考证

“风癔”的病名源起有二。其一，源于本病发作时的声音。“风癔”最早见于隋代巢元方的《诸病源候论·风癔候》：“风邪之气，若先中于阴，病发于五脏者，其状奄忽不知人，喉里噫噫然有声，舌强不能言。”[1]其中“噫噫然”形容说话困难，言语不清，只能发出“噫噫”声的样子。由于“噫”与“癔”“懿”音同，模拟了本病发作时的特定声音，故为命名依据之一。其二，指代了本病风邪中脏的病机。唐代孙思邈在《备急千金要方》中将“风癔”作为中风的基本类型：“中风大法有四，一曰偏枯，二曰风痺，三曰风懿，四曰风痹……风懿者，奄勿不知人，咽中塞窒窒然”[2]127。“懿”通“噫”，且有“深”之意，其部首为心，与神志相关，病位较深，这表明“风懿”描述的是风邪深入，损害神志的重病。自宋代《太平圣惠方》始，“风癔”逐渐取代“风懿”被历代医家载入医籍。“癔者，心意病也”[3]，即神志昏聩，病情较重，与“风懿”所描述的病机相符。

综上所述，“风癔”作为中风证候之一首见于《诸病源候论》，其病名既源于患者发病时因言语困难而发出“噫噫”声之外候，更深刻揭示了风邪中脏损及神志等病机之内候。不同历史时期演化出的“风懿”与“风癔”两种病名，本质上都描述了风邪中脏所致的言语障碍。

临床特征

1. 言语障碍与意识障碍　“风癔”的主要表现之一为突发性言语障碍，病情重者可伴意识障碍。隋代《诸病源候论》首

通信作者：陈仁寿，江苏省南京市栖霞区仙林大道138号南京中医药大学中医药文献研究院，邮编：210023，电话：025-85811753
E-mail：njcrs@126.com

中国知网 https://www.cnki.net

次记载了“风癔”的临床表现：“其状奄忽不知人，喉里噫噫然有声，舌强不能言”[1]，“奄忽”即“突然”，“不知人”即神志不清。唐代《备急千金要方》描述为“咽中塞窒窒然”[2]141，即咽喉堵塞一样发不出声音。这些发病特点在宋代官修方书中也可见一二，如《太平圣惠方·治风癔诸方》中记载：“舌强不能言……心神恍惚，不知人”“咽喉作声，言语蹇涩，心胸不利”“迷闷不识人”“咽中作声，舌强语涩，心膈不利”[4]262；《圣济总录·风癔》中记载：“舌强不语，昏冒不知人，喉中作声”“口不能语”“精神不明”“精神冒闷”[5]267。由此可见，“风癔”一般是猝然起病，即刻出现言语障碍，并伴有神志问题。而且其言语障碍存在轻重程度之分，如“咽喉作声，言语蹇涩”“咽中作声，舌强语涩”较“舌强不语”“口不能语”而言程度更轻。综上，根据“风癔”轻、重度言语障碍的不同病状，可对照现代言语病理学中的不同分型对其言语障碍类型进行初步推测。如轻度的言语障碍有“咽喉作声，言语蹇涩，心胸不利”“咽中作声，舌强语涩，心膈不利”[5]267等表现，多属于舌肌或口唇运动障碍所致的言语不清或构音困难，不存在神志问题，可归于现代言语病理学中的构音障碍范畴；而重度的言语障碍有“舌强不能言……心神恍惚，不知人”“舌强不语，昏冒不知人，喉中作声”[4]262,[5]267等神志不清的表现，则更接近现代言语病理学中的失语症。

2. 肢体瘫痪与感觉缺失　“风癔”的另一主要临床表现为肢体瘫痪，有时可伴感觉障碍。唐代《备急千金要方》载：“四肢不收、手足䠶曳。”[2]“不收”指四肢瘫痪，无法收拢；“䠶”为“下垂”，“䠶曳”即因手足瘫痪而痿软无力的表现。宋代《太平圣惠方》《圣济总录》中对风癔的描述增加了一些硬瘫的特征，如“四肢拘急”“舌强不能言”“舌强语涩”“体强不知人”等。由此推测，“风癔”的肢体瘫痪包括软瘫与硬瘫两型，即弛缓性瘫痪和痉挛性瘫痪。

“风癔”的瘫痪还可伴感觉障碍，如《圣济总录·风癔》云：“冒昧不知痛痒”[5]267；清代《石室秘录》曰：“风懿之症……不疼不痛，卧于床褥之上，亦终岁经年”[6]。这种痛觉减退或消失的症状与后循环脑血管病变所致的感觉障碍十分相似。

3. 脑水肿表现　“风癔”的临床特征中还包括脑水肿表现。《诸病源候论·风癔候》中记载了“风癔”的轻重两型：“发汗身软者可治，眼下及鼻中左右白者可治”“一黑一赤，吐沫者，不可治。汗不出，体直者，七日死”[1]1。其中重症不治的表现与现代急性脑血管病中的脑水肿表现非常相似，如面部“一黑一赤”，类似脑室出血引发的皮肤紫绀；“吐沫”可为颅内压增高而产生的呕吐；“体直”则与脑桥出血引起的去大脑强直、小脑幕裂空疝导致的四肢强直相近。

病因病机

1. 风中脏腑说　唐宋时期，医家多从“风”立论，认为“风癔”是外风乘虚侵袭脏腑，阻碍经脉气血运行所致。其病因“或因喜怒，或因忧思，或因惊恐，或饮食不节，或劳役过伤，遂致真气先虚，荣卫失度，腠理空疏，邪气乘虚而入”[7]13。其病机为风邪“先中于阴”，犯太、少、厥三阴经，后“病发于五脏”[1]1，“风邪与血气相搏，经脉凝泣，阴阳之气，不得偕行，营卫不流”[5]267。“邪中心肺，涎潮逼塞”[8]，肺气不能入心，故猝然昏倒而不能言；“风邪乘虚，入其筋则挛”[9]，故舌强口噤；邪入脾肾，营卫不能流于肌肉，故四肢瘫痪；邪入心包，痹阻心窍，故神昏而不知人。

2. 痰阻心窍说　金元时代，“内风”学说兴起，孙思邈关于“偏枯”“风痺”“风癔”“风痹”为中风四法之说逐渐被“真中”“类中”等概念所替代，故对“风癔”因机鲜有论述。不过随着明清医家对“风癔”病因病机论述的重启，“痰阻心窍”逐渐成为了主流观点。如明代《济阳纲目》云：“卒倒歪斜不语，名风癔……痰由水化制火，闭塞心窍不语”[10]308，清代《奇效良方》曰：“三曰风懿者……痰涎上迷心窍……气不升降，病在脏腑”[11]，清代《杂病源流犀烛》根据虚实分出了“痰热”与“虚痰”两型：“风懿病有由于热者，则以痰火郁积而然，非清火不可；有由于虚者，则以元弱痰横之故，非化痰不可”[12]。

治法方药

1. 祛风通络，解表通里　唐宋时期，“风癔”多从风论治，行祛风通络、解表通里之法，常将活血通络药与发汗祛风药配伍使用，如《圣济总录·风癔》所云：“身软而汗，则表里疏通，筋脉和缓，阳气得复，故可治也”[5]267。最早的治疗方剂是载于唐代《备急千金要方》的“独活汤”，由“独活四两，桂心、芍药、栝蒌根、生葛各二两，生姜六两，甘草三两”组成[2]141，即瓜蒌桂枝汤去大枣，改桂心，加独活、葛根。独活胜风，配伍葛根舒筋通络，桂心入心包而开心窍。全方既能祛风和营，又能通络开窍。此后，宋代《太平圣惠方》《圣济总录》中又载“麻黄散”“桂心散”“防风汤”等治“风癔”专方，组方思路多与千金独活汤相似。对于神志昏迷、不省人事的重症患者，则以大量清热息风、重镇安神药配伍芳香药开窍醒神。如《圣济总录》所载“金箔丸”，以金银箔各一百片为君，配伍犀角、牛黄、丁香、龙脑、沉香、真珠末、木香、麝香、琥珀、硼砂、乌蛇、大麻、雄黄、蝎梢、白僵蚕、附子、天南星、防风、白附子、甘草、丹砂等24味药炼蜜丸，以薄荷酒为饮服用，可治“奄忽不知人，喉中噫噫然有声，舌强不能言，身软自汗，口吐涎沫，项背强直，神志昏愦”[5]268。

对于牙关紧急、汤药不能下咽的“风癔”患者，古代医家常用“搐鼻法”辅助治疗，“俟其喷嚏，即以稀涎散灌之”[7]14。如《圣济总录》所载的“桂末吹鼻方”“石菖蒲末吹鼻方”，即取药末半两，少量吹入患者鼻腔，通过喷嚏刺激张口，便于给药。

2. 化痰开窍，行气补虚　金元以后，医家多认为“痰”是“风癔”的病机关键，故遣方用药多用化痰开窍、补虚行气之法，若有热者加以清热。如明代《济阳纲目》提出“风癔”属“热

中国知网 https://www.cnki.net

者，凉膈散加黄连，或牛黄清心丸”；属“虚者，星香散、三生饮、导痰汤、小省风汤”[10]308。清代《证治汇补》认为应“以涤痰汤、八味顺气散主之”[13]。清代医家沈金鳌对《太平惠民和剂局方》所载的八味“牛黄清心丸”进行了加味，作为治疗“风癔”痰火证的专方。原方之牛黄、金箔、麝香、犀角、雄黄、龙脑、羚羊角、蒲黄能清热息风、豁痰开窍，再加人参、茯苓、麦冬、山药、胆南星、白术、朱砂、甘草等健脾化痰、益气安神之品，更能针对“风癔”虚实夹杂的病机行补虚泄实之功。《全国名医验案类编·中风闭证案》中载有高糺云以牛黄清心丸治愈商人潘世杰中风闭证一案。患者猝然昏倒，舌强不言，喉中痰塞，噫噫有声，四肢微瘛，不省人事。结合脉浮滑数，右寸尤甚，舌苔黄滑，高糺云判断为元气素弱，久患痰火郁积，适中外风，引动内风而猝发之“风癔”。行以息风清热、搜剔络痰之法，方用二参竹沥汤送服牛黄清心丸。“一剂，神识醒。去牛黄丸，再服二剂，各症减。三剂，语言清亮。”[14]

“风癔”考证的临床意义

现代医学中没有与“风癔”明确对应的疾病，但其发病特点与现代临床急性脑血管病中的后循环脑血管病变的临床表现具有高度关联性。康蕾等[15]认为“风癔”奄忽不知人，发病急骤，神智丧失，舌强不能语，喉中痰浊梗阻等症状类似于出血性中风，尤其与脑血管后循环缺血的头晕、肢麻无力甚至瘫痪、短暂意识丧失、视觉障碍、构音困难、吞咽困难、声音嘶哑等症状相似；朱东强等[16]也认为“风癔”与后循环脑血管病变相似，其病位深在脏腑，相当于基底动脉尖综合征、大面积脑梗死或大量脑出血等脑卒中重症，而其言语症状则类似脑卒中后的失语症或构音困难。申斐等[17]认为“风癔”与脑小血管病的突然眩晕、运动障碍、感觉障碍、共济失调及构音障碍或缓慢出现的精神障碍、认知能力下降等临床症状重合度很高。实践中，牛黄清心丸在治疗以上疾病中发挥了至关重要的作用。据临床报道，以牛黄清心丸辅助治疗急性脑出血可有效改善患者的神经功能及意识状况[18]，对于急性脑梗死的治疗具有良好的协同增效作用，能够改善患者神经功能，提高患者日常活动能力[19]。综上，从文献角度深入考证“风癔”的因机证治，发掘有效方药，对于上述疾病的治疗，具有重要的启发和借鉴意义。

参 考 文 献

[1] 隋·巢元方.诸病源候论.黄作阵,点校.沈阳:辽宁科学技术出版社,1997

[2] 唐·孙思邈.备急千金要方.鲁兆麟,主校.沈阳:辽宁科学技术出版,1997

[3] 明·梅膺祚,撰.清·吴任臣,编.字汇.上海:上海辞书出版社,1991:63

[4] 宋·王怀隐,等,编.太平圣惠方校注3.郑州:河南科学技术出版社,2015

[5] 宋·赵佶,倎撰.圣济总录第2册.王振国,杨金萍,主校.北京:中国中医药出版社,2018

[6] 清·陈士铎.石室秘录.张灿玾,等,点校.北京:中国中医药出版社,1991:335

[7] 宋·严用和.重订严氏济生方.北京:人民卫生出版社,1980

[8] 宋·陈言.三因极一病证方论.北京:人民卫生出版社,1957:21

[9] 清·张璐.张氏医通.李静芳,建一,校注.北京:中国中医药出版社,1995:6

[10] 明·武之望.济阴济阳纲目.苏礼,主校.北京:中国中医药出版社,1995

[11] 清·董宿,辑录.奇效良方.杨文翰,校正.北京:中国中医药出版社,1995:1–3

[12] 清·沈金鳌.杂病源流犀烛.李占永,李晓琳,校注.北京:中国中医药出版社,1994:183

[13] 清·李用粹.证治汇补.上海:上海卫生出版社,1958:3

[14] 何廉臣,编写.全国名医验案类编.太原:山西科学技术出版社,2011:11

[15] 康蕾,杨仁义,陈思肴,等.《奇效良方》辨治中风病学术思想探析.中国中医急症,2020,29(6):1095–1097

[16] 朱东强,宋丽晶,于大川.对脑卒中病的再认识.吉林中医药,2009,29(10):829–830

[17] 申斐,关东升,李歌,等.脑小血管病中医病名探析.医学争鸣,2021,10(3):1–7

[18] 沈海平,易昌容.牛黄清心丸辅助治疗急性脑出血临床观察.新中医,2018,50(11):59–62

[19] 史若愚.牛黄清心丸联合依达拉奉治疗急性脑梗死的临床研究.现代药物与临床,2021,36(9):1826–1829

（收稿日期：2023年11月8日）

中国知网 https://www.cnki.net